



Université Constantine « 3 »
S alah Boubnider F aculté de
Médecine/Département de
Médecine



العلوم الطبية
قسنطينة
FACULTÉ DE MÉDECINE
CONSTANTINE

L'OCCLUSION INTESTINALE AIGUE

Dr M. S . DJ EBAILI
Médecine Interne



Plans

Définition

Mécanisme

Étude sémiologique

Principales causes

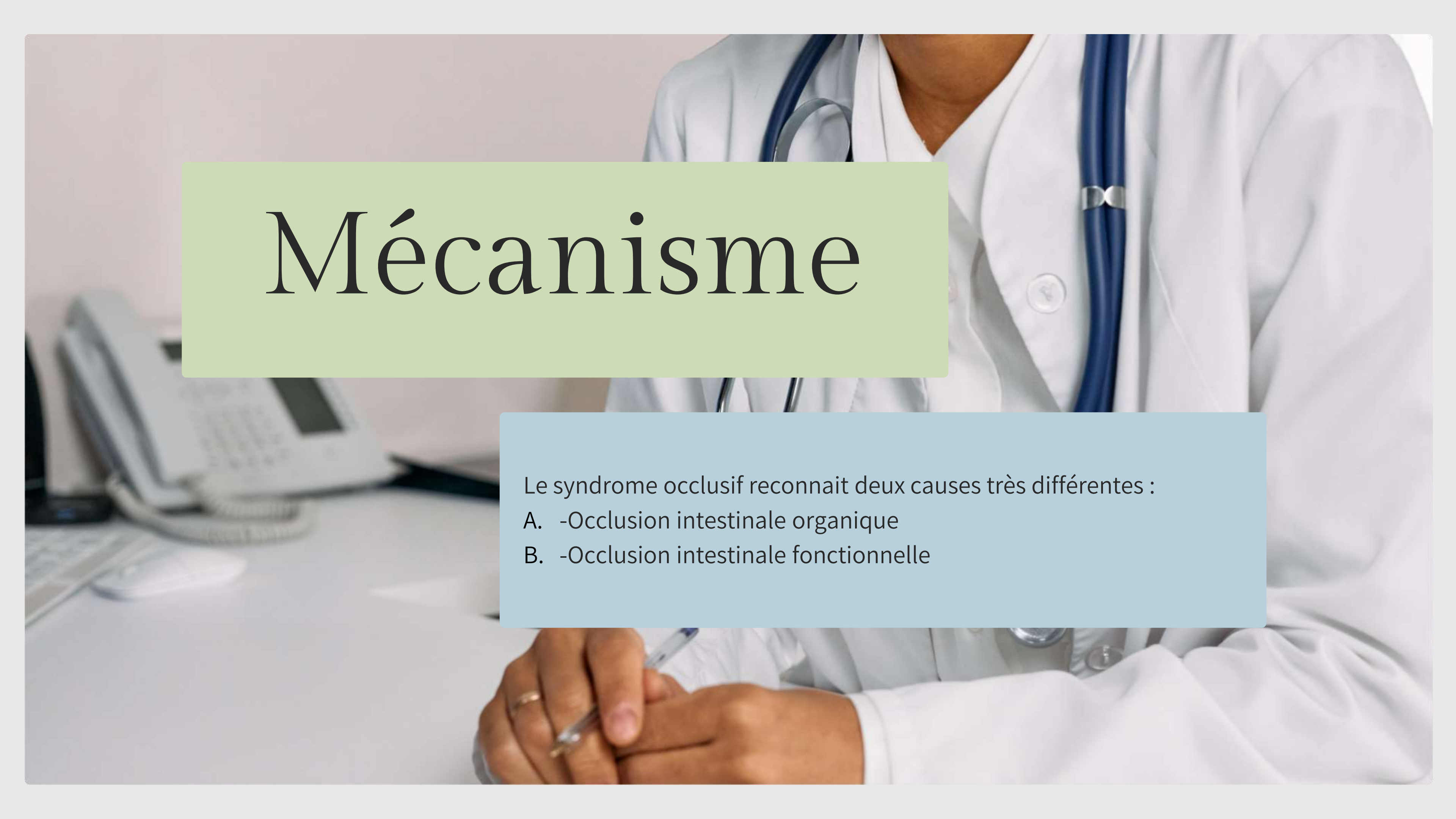
Conclusion





Définition

L'occlusion intestinale aigue(OIA) est l'arrêt du transit, des matières et des gaz
urgence médico-chirurgicale pouvant mettre en jeu le pronostic vital

A doctor in a white coat with a stethoscope, sitting at a desk with a computer and a telephone.

Mécanisme

Le syndrome occlusif reconnaît deux causes très différentes :

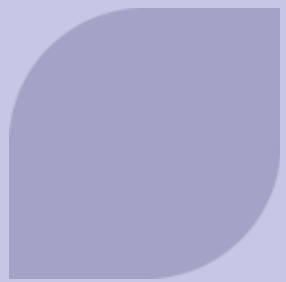
- A. -Occlusion intestinale organique
- B. -Occlusion intestinale fonctionnelle

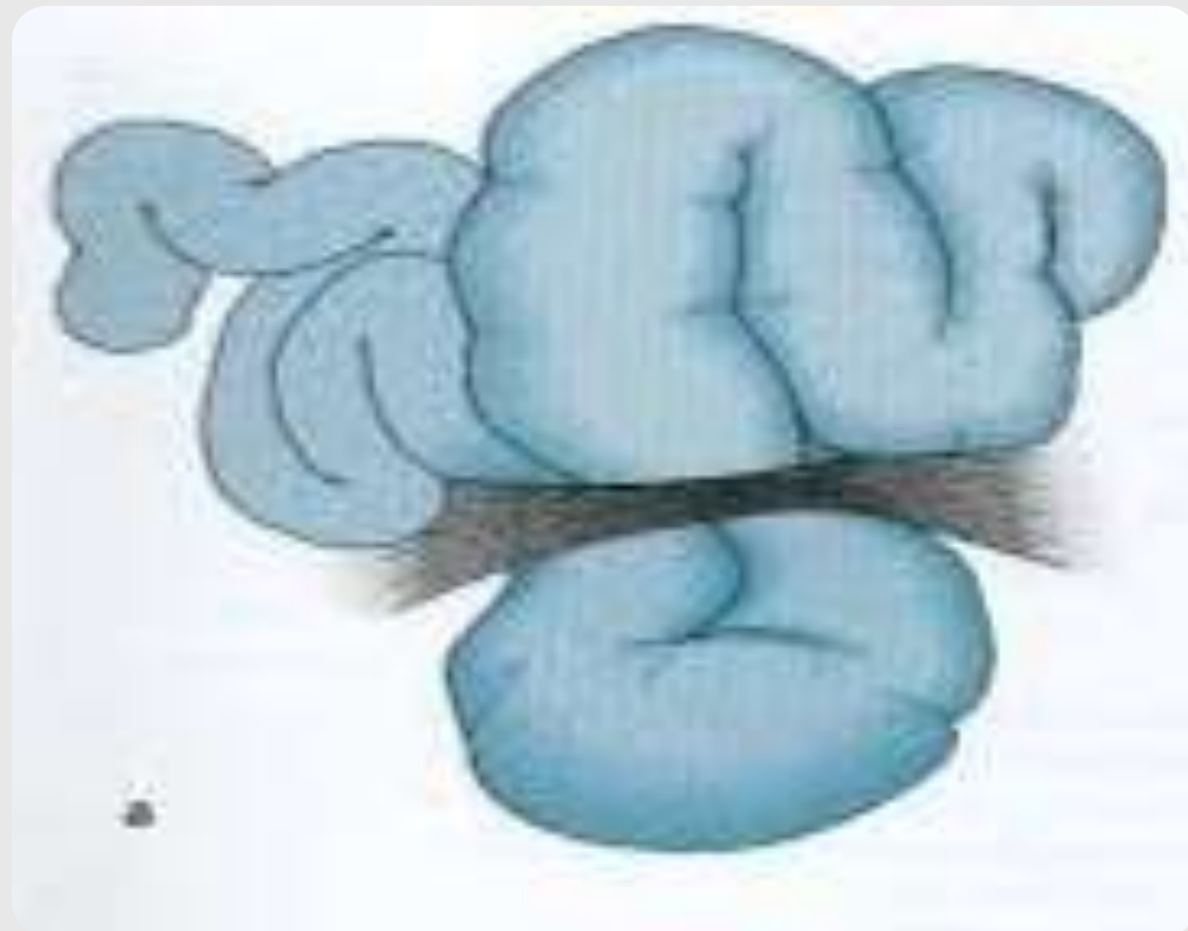
A -Occlusion intestinale organique :

Un obstacle interrompt le transit au niveau du colon ou du grêle.

Deux mécanismes :

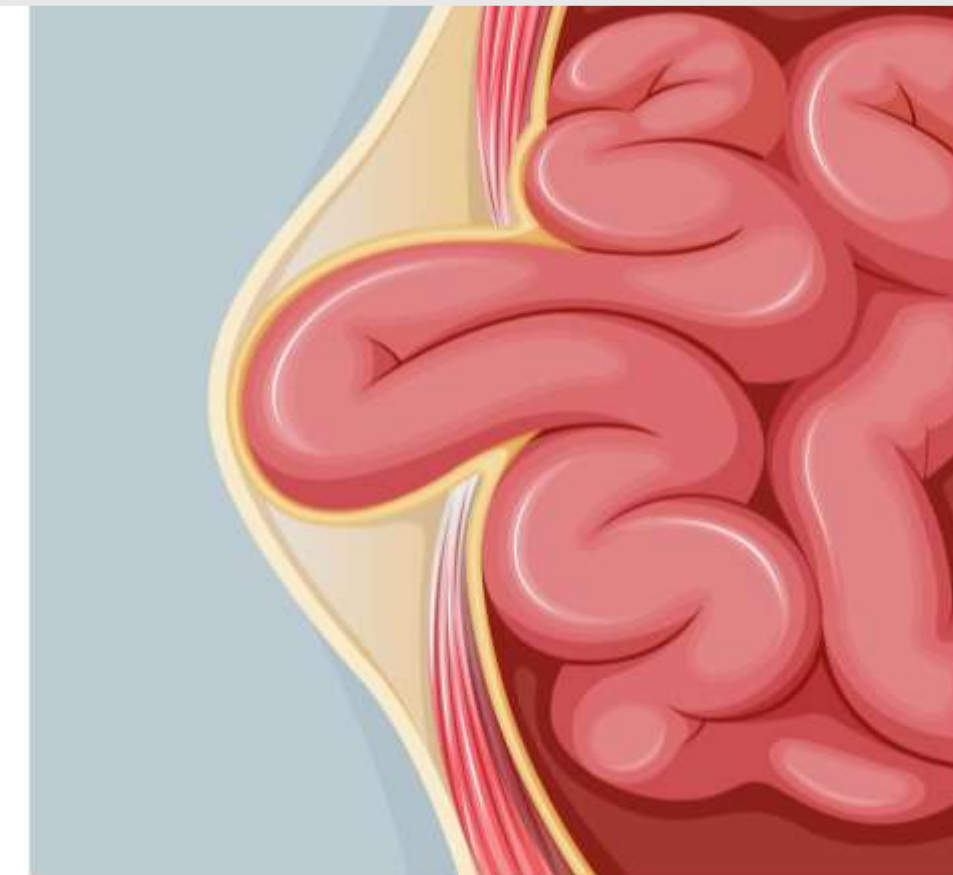
1 /Occlusion par strangulation :





UN VOLVULUS

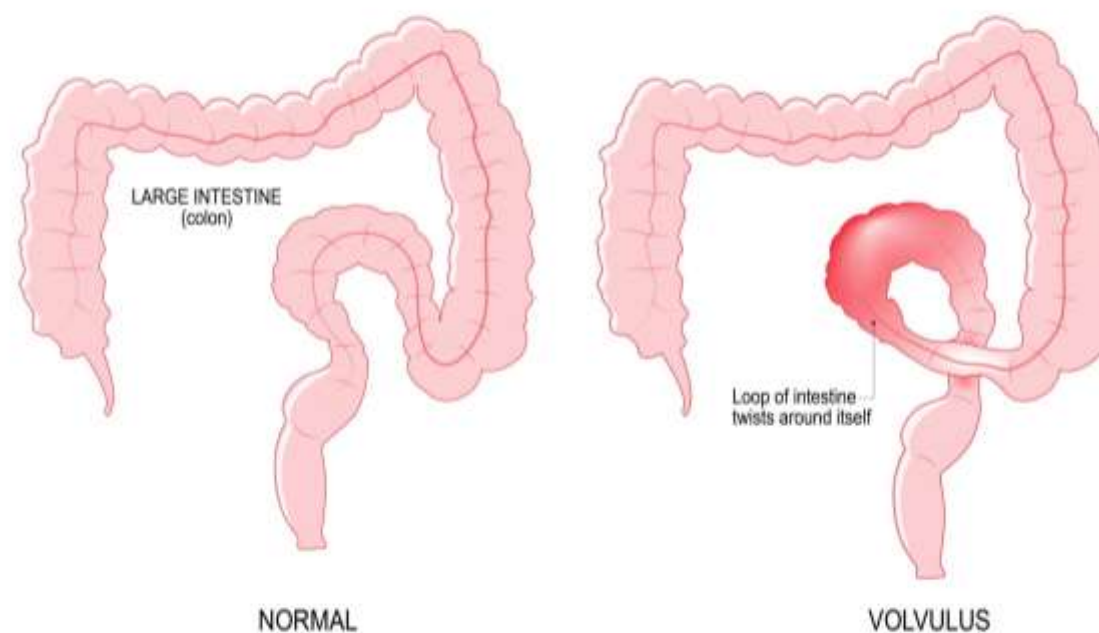
torsion de l'intestin sur lui-même



BRIDE

cicatrice fibreuse secondaire à une intervention chirurgicale

VOLVULUS



UN ETRANGLEMENT HERNIAIRE

étranglement de l'intestin dans un orifice herniaire

A -Occlusion intestinale organique :

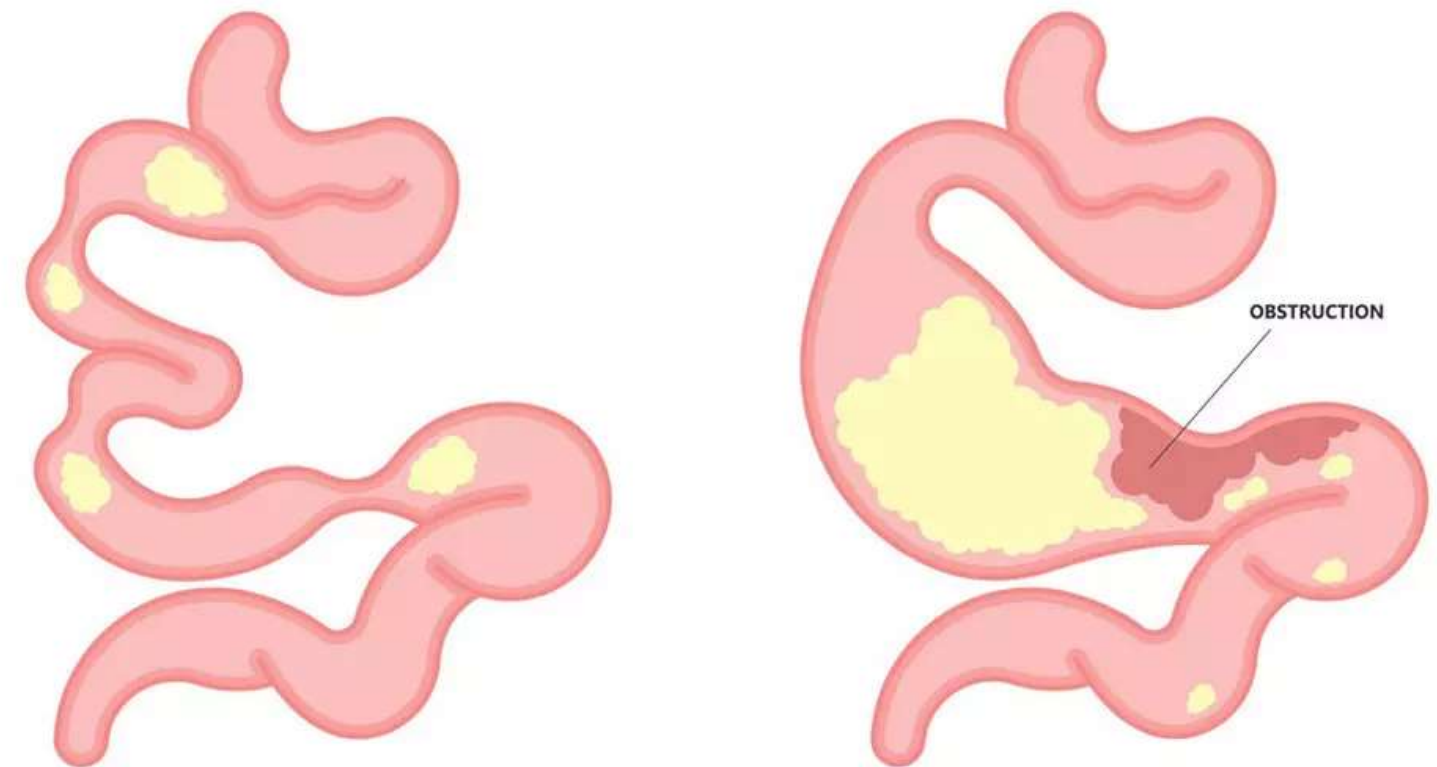
Un obstacle interrompt le transit au niveau du colon ou du grêle.

Deux mécanismes :

2 /Occlusion par obstruction de la lumière :

La cause la plus fréquente est une tumeur intestinale

Obstruction de l'intestin grêle



Intestin normal

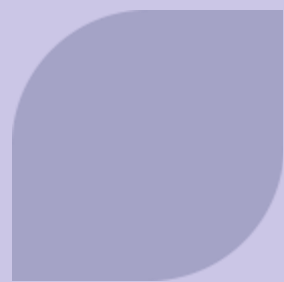
Blocage dans l'intestin grêle

B -Occlusion intestinale fonctionnelle :

Il n'y a pas d'obstacle mais une paralysie des muscles de l'intestin entraînant l'absence de progression : iléus

1 /Contexte infectieux d'irritation : péritonite

2/Troubles hydro électrolytiques : hypokaliémie



INTESTINAL OBSTRUCTION



intestinal obstruction



crampy abdominal pain



loss of appetite



constipation



vomiting



inability to have a bowel movement



abdominal swelling



intestinal adhesions



hernias



intussusception



volvulus



colon cancer



physical examination



X-ray



air or barium enema



surgery

ETUDE SEMIOLOGIQUE



A -Clinique :

Le syndrome occlusif aigue se caractérise par

1 /La triade symptomatique fonctionnelle :

Les douleurs abdominals : constantes, début plus ou moins brutal, intensité variable évoluant par crise paroxystiques, témoignant de la lutte de l'intestin contre l'obstacle, entre les crises persiste un fond douloureux permanent

Les vomissements : précoces ou tardifs, alimentaires, bilieux ou fécaloïdes

L'arrêt des matières et des gaz



2 /Les signes généraux :

Altération de l'état général

Signes de deshydratation : sensation de soif, pli cutané

3 /Les signes physiques :

L'inspection :

- Cicatrice d'intervention chirurgicale
- Ballonnement abdominal central / périphérique, majeur ou absent (occlusion haute), asymétrique, ondulations péristaltiques (sujet maigre)

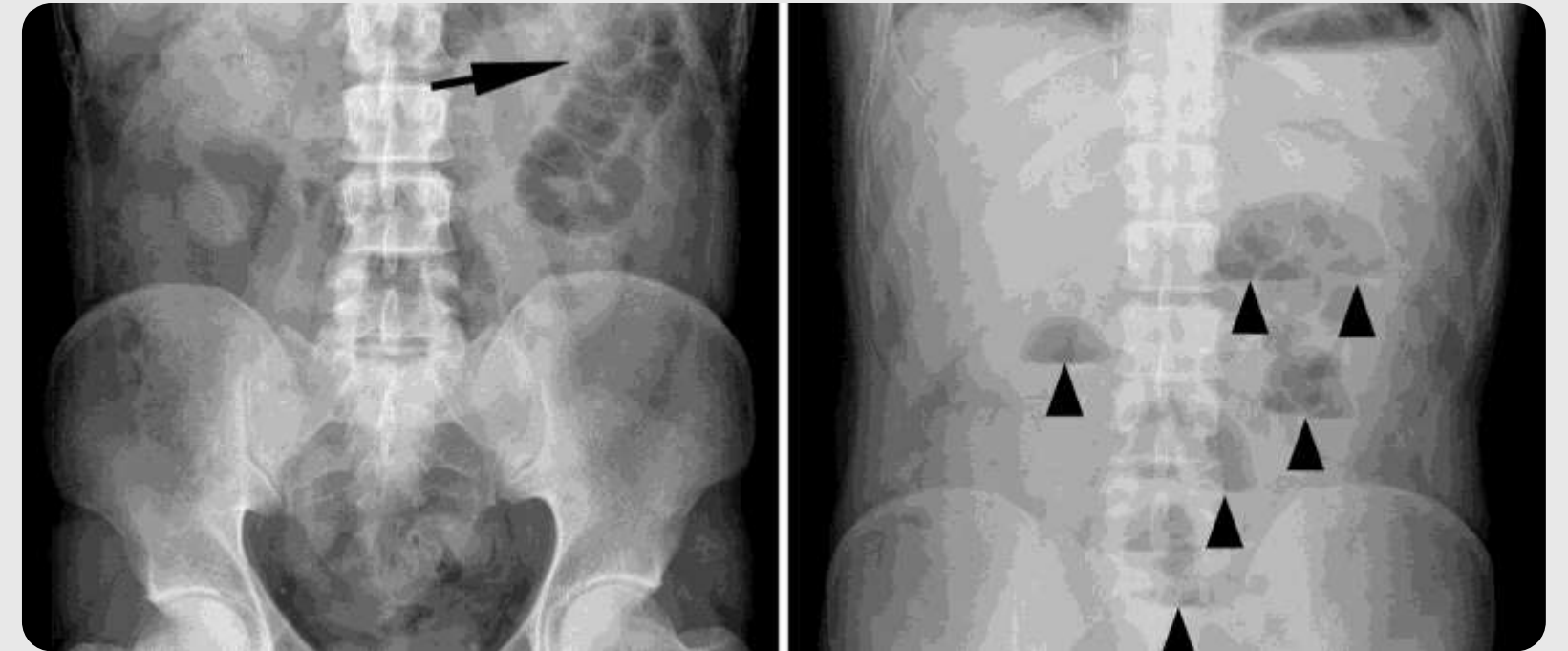
La palpation : Recherche une douleur, une défense, une masse, explore les orifices herniaires

La percussion : Recherche un tympanisme

L'auscultation : Gargouillement « borborygmes », ou silence abdominal (strangulation)

Les touchers pelviens : Toucher vaginal et rectal : masse

B -Les examens complémentaires :



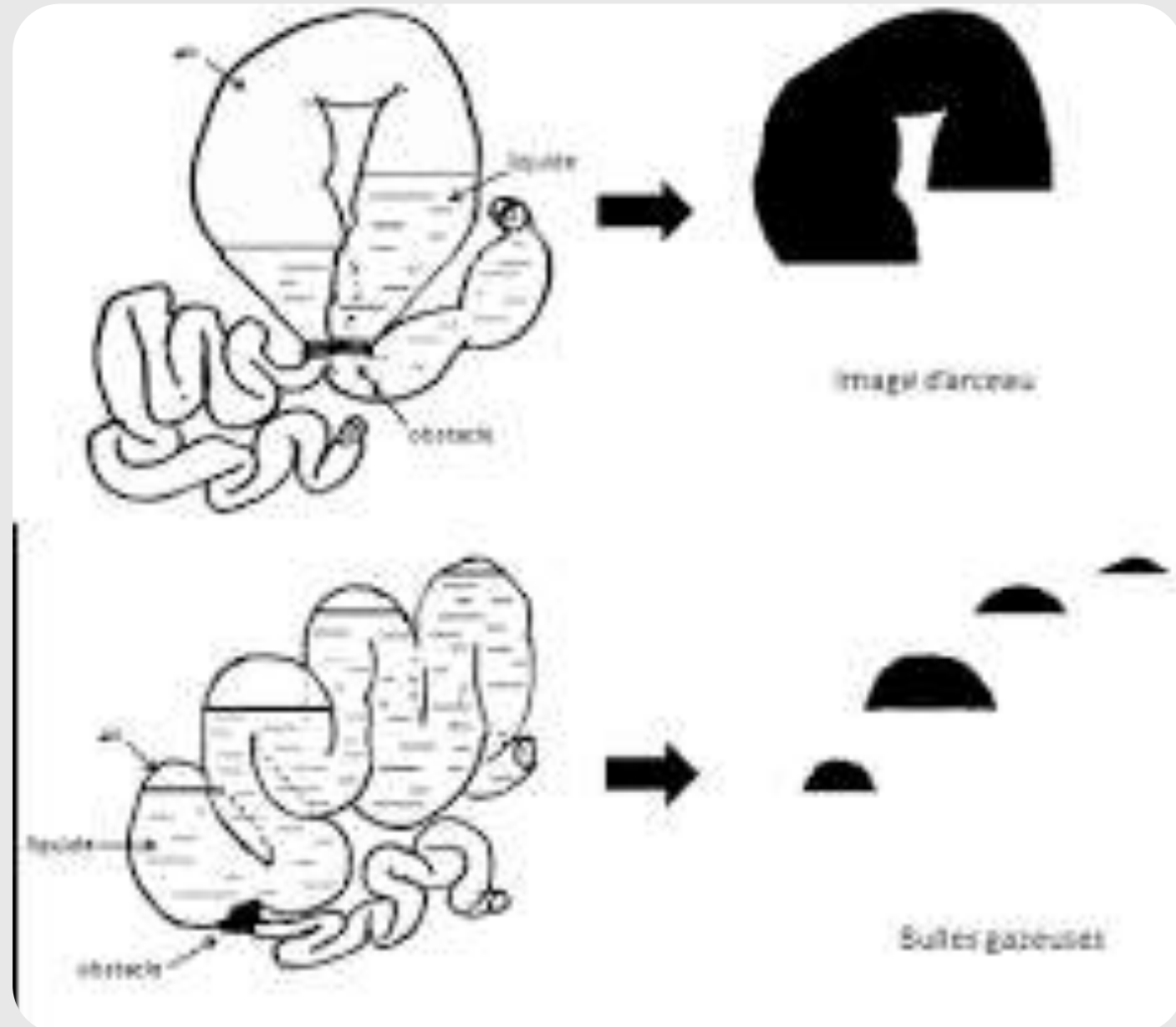
1 /La radiologie :

L'ASP

l'abdomen sans préparation debout face : Niveaux hydro-aériques

L'échographie abdominale

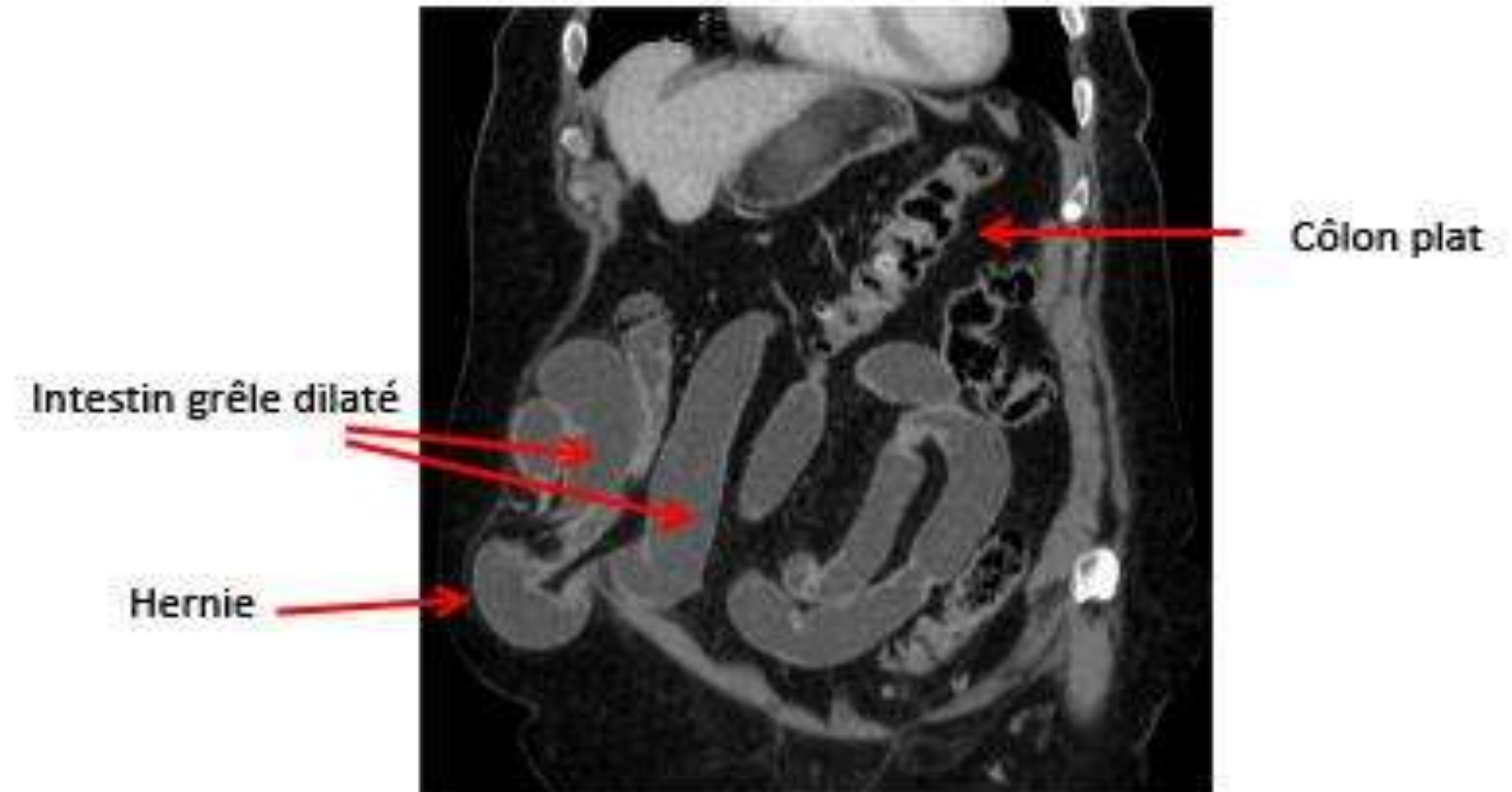
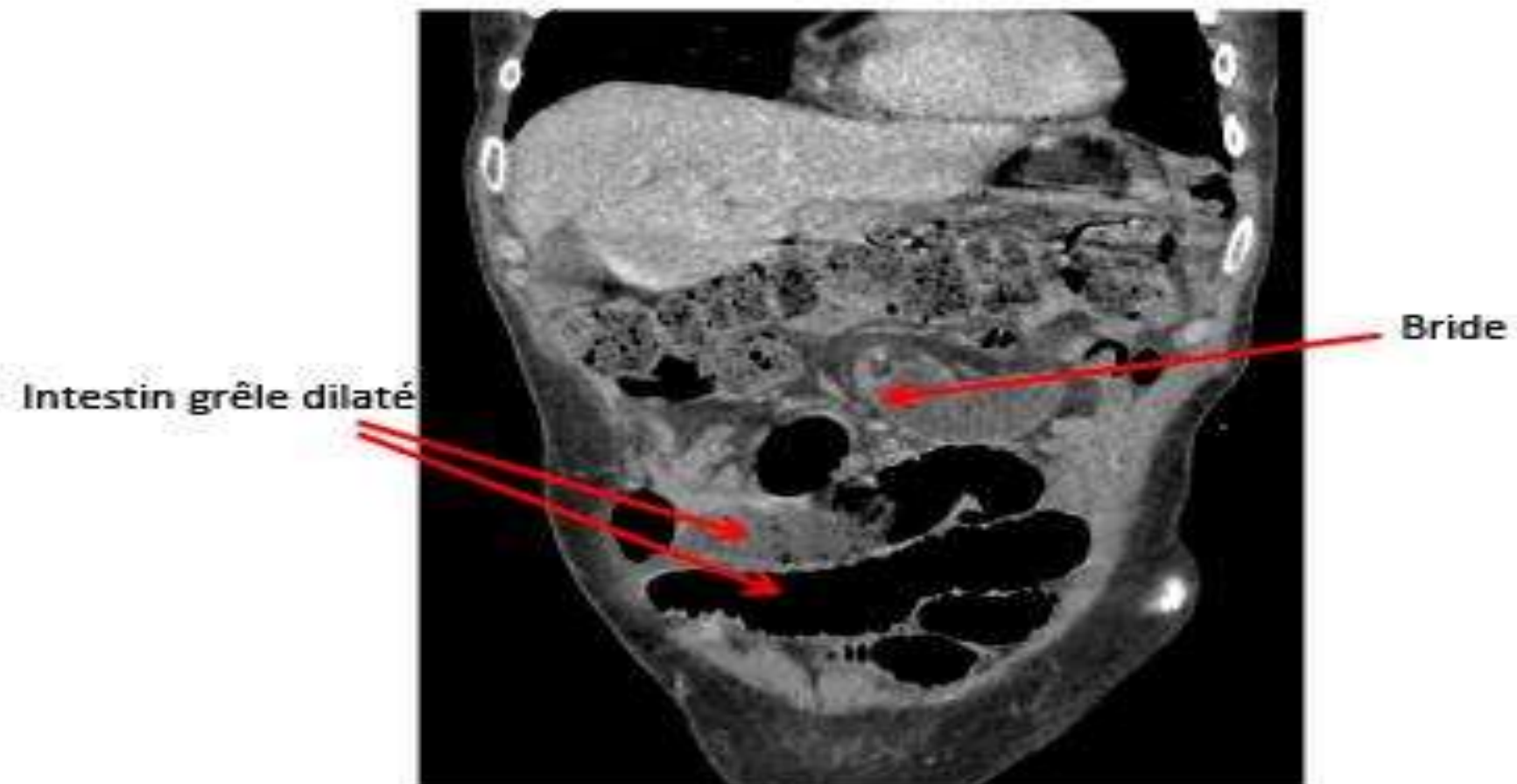
n'a pas d'intérêt, les gaz empêchent la transmission des ultrasons



L'examen tomodensitométrique

de plus en plus utilisé, utile pour préciser

- le niveau de l'obstacle : jonction entre l'intestin dilaté d'amont et l'intestin plat d'aval.
- la nature de l'obstacle (syndrome de masse en cas d'obstacle tumoral, aspect de torsion du méso en cas de volvulus).





2/Biologie :

F N S

hyperleucocytose, anémie

Ionogramme sanguin

hypokaliémie

Bilan préopératoire

Groupage rhésus, bilan rénal

Au terme de l'examen clinique et des examens para cliniques : Selon le siège de l'occlusion, on a différents tableaux cliniques :



L'occlusion fonctionnelle

- Mécanisme : Paralysie de la musculature intestinale
 - Signes fonctionnels : Indolore, arrêt des matières, sans arrêt absolu des gaz
 - Signes physiques : distension abdominale intéressant le colon et le grêle
 - ASP : Pas de niveaux hydroaériques, distension intestinale globale

L'occlusion du colon

- Mécanisme : obstruction
 - Signes fonctionnels : Douleurs abdominales à début progressif, intensité peu marqué, vomissements tardifs, arrêt des matières et des gaz précoces
 - Signes physiques : Météorisme abdominal très important, périphérique puis diffus
 - ASP : Distension gazeuse, niveaux hydroaériques périphériques peu nombreux

L'occlusion du grêle

- Mécanisme : strangulation
- Signes fonctionnels : début brutal, aigue, les douleurs intenses, vomissements précoces, arrêt des matières et des gaz tardifs, altération de l'état général
- Les signes physiques : Le météorisme abdominal : localisé, central, discret
- ASP ; niveaux : centraux, nombreux, de petite dimension, il n'y a pas de distension colique



LES PRINCIPALES CAUSES

L'occlusion du nouveau né

à la naissance, dès les premières heures

- Imperforation anale
- Atrésie de l'intestin grêle
 - Sténose duodénale
- Maladie de HIRSCHPRUNG :
Maladie congénitale caractérisée par l'absence des ganglions nerveux qui contrôlent les muscles lisses de l'intestin.

L'occlusion du nourrisson

(enfant de moins de 1 an)
Invagination intestinale aigue :
Crise douloureuse aigue, arrêt des matières et des gaz, refus de biberon

L'occlusion de l'enfant

Rares surtout fonctionnelles :
appendicite

L'occlusion de l'adulte

1 /Les occlusions du grêle : essentiellement par strangulation

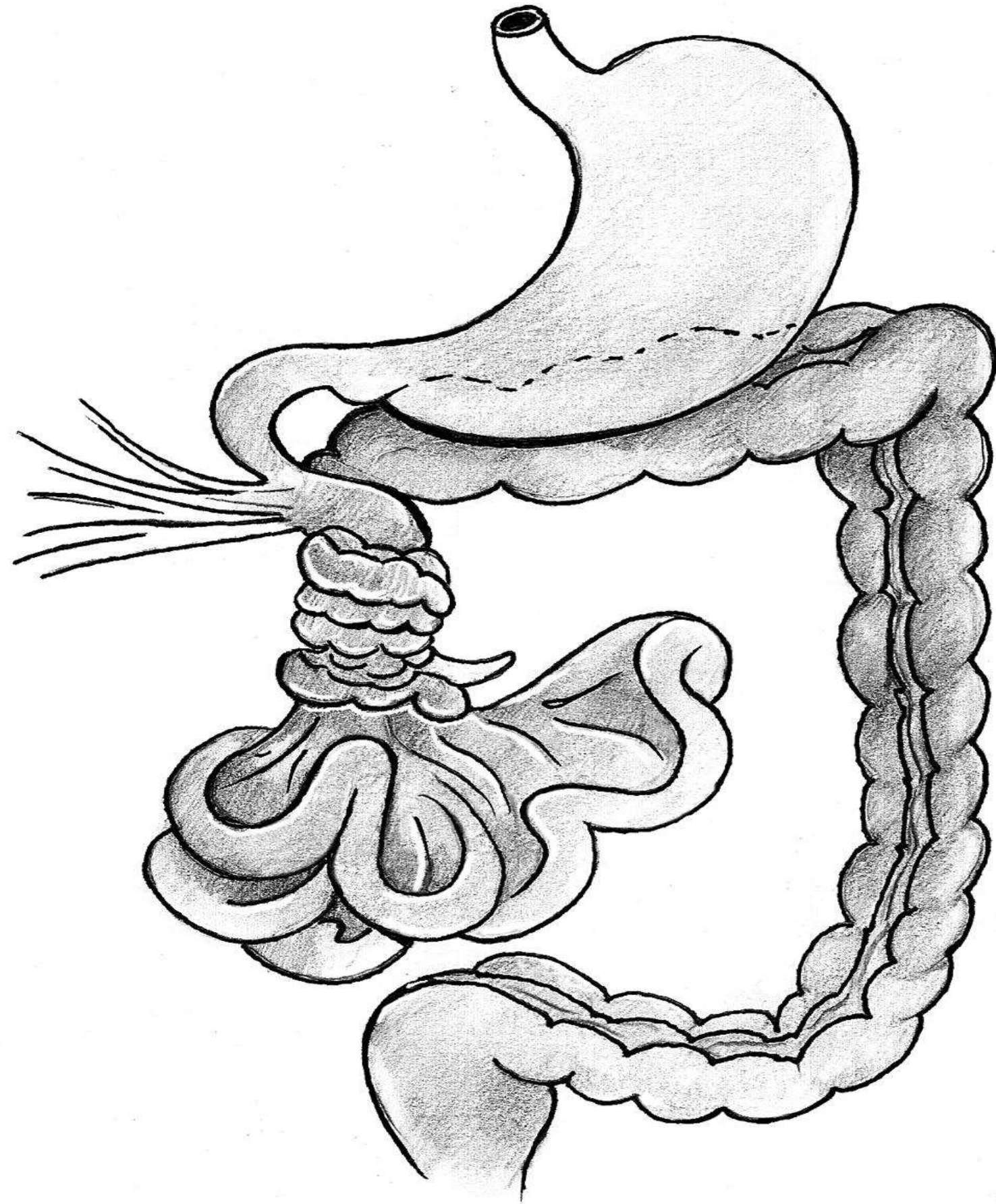
- Occlusion sur bride post opératoire
- Etranglement herniaire (crurale)
- Rarement obstruction : tumeur, corps étranger

2 /Les occlusions du colon :

- Obstruction : cancer du colon, sigmoïde, rectum, corps étranger
- Rarement : sujet âgé : volvulus du colon pelvien

3 /Les occlusions fonctionnels :

- Réactionnels à un processus infectieux : abcès, appendicite, péritonite
- Troubles hydroelectolytiques : Hypokaliémie
- Postopératoires : iléus normal 3-4 jours, au-delà risque de devenir organique



CONCLUSION

- Syndrome abdominal fréquent
- Urgence médico chirurgicale
- Un bon examen clinique et des examens complémentaires de qualité
- Une prise en charge précoce

THANK
YOU

